

L'Infanzia: Sviluppo psicoaffettivo, relazioni primarie e teoria dell'attaccamento

I Tempi della Vita · Sessione 04 · Ottobre 2025

Questa lezione è un bel pezzo di viaggio: partiamo dal corpo del neonato — bocca, pancia, sensazioni — e arriviamo alle radici più profonde di come ci leghiamo agli altri. Freud, Winnicott, Bowlby, Ainsworth, Stern: visioni diverse che, messe insieme, ti danno una mappa potente dello sviluppo del bambino. Impararla bene significa capire molto di quello che vedrai sul campo.

1. La posizione originale della psicoanalisi: Freud e lo sviluppo psicosessuale

Questioni metodologiche

Freud lavora "nell'après-coup" — cioè a ritroso. La sua teoria dello sviluppo del bambino **non** nasce dall'osservazione diretta di molti bambini come fa la ricerca moderna, ma viene ricostruita a partire da: - l'autoanalisi di Freud stesso, - i sogni e i sintomi dei suoi pazienti adulti.

È una prospettiva radicale: la psicoanalisi si avvicina allo sviluppo privilegiando **affettività e sessualità** — due temi che ai suoi tempi erano tabù.

La pulsione (Trieb)

Pulsione — dal latino *pulsio* (spingere), in tedesco *Trieb* (impulso, germoglio) — è uno stato di eccitazione dell'organismo, una spinta energetica che fa tendere l'organismo verso qualcosa. Sta al confine tra psichico e somatico.

La **libido** (in latino: desiderio, voglia) è la manifestazione dinamica della pulsione sessuale nella vita psichica.

"La dottrina delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitologia. Le pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza." — Freud, *Compendio di psicoanalisi*, 1938

Nei testi tardivi Freud teorizza due pulsioni fondamentali: - **Eros** (pulsione di vita): tende a complicare e conservare la vita, aggregando unità sempre più vaste. - **Thanatos** (pulsione di morte): tende a ricondurre il vivente allo stato inorganico.

Gli stadi dello sviluppo psicosessuale

Pensa agli stadi come alle **fasi di crescita di una pianta**: ogni fase mette radici in una zona del corpo, e quelle radici rimangono anche quando la pianta cresce. Le fasi non spariscono — si integrano.

Stadio	Età	Zona erogena	Temi psico-affettivi chiave
Narcisismo primario	Nascita	—	Mondo centrato sul sé
Fase orale	0-2 anni	Zona bucco-labiale	Incorporazione, introiezione, suzione
Fase sadico-anale	18 mesi - 4 anni	Zona anale/viscerale	Trattenere/espellere, attività/passività, controllo
Fase fallico-uretrale	3-5 anni	Genitali	Presenza/assenza del pene, potenza narcisistica
Complesso di Edipo	~4 anni	—	Triangolo relazionale, limiti, differenze di genere e generazione
Fase di latenza	6-12 anni	—	Rimozione, investimento nell'apprendimento

Stadio	Età	Zona erogena	Temi psico-affettivi chiave
Sessualità genitale	Pubertà	—	Integrazione delle pulsioni in sessualità matura

La fase orale in profondità

Dal bisogno fisiologico di nutrirsi si organizza un piacere erotico. La bocca diventa la prima **zona erogena**: il bambino non succhia solo per nutrirsi, ma per piacere. Il prof usa un esempio concreto: il bacio — appoggiare le labbra sulla bocca di qualcuno — è la sopravvivenza adulta di questo primissimo piacere orale.

La fase sadico-anale

Intorno alle vicende del **trattenere e concedere** — legate all'educazione alla pulizia — si organizza una certa ambivalenza: attività/passività, ritenzione/espulsione. Le parolacce e gli insulti scatologici in molte culture sono la traccia adulta di questa fase.

Lo stadio fallico e il Complesso di Edipo

Il **Complesso di Edipo** — ispirato alla tragedia di Sofocle — è la struttura che organizza il mondo psichico intorno al **limite**: - Dal "tutto è possibile" → al "non posso avere, ma posso sognare, creare, fantasticare". - Dalla relazione **duale** (io + mamma) alla relazione **triangolare** (io + mamma + papà, e da certe cose sarò escluso).

"Il destino di Edipo ci commuove perché sarebbe potuto diventare anche il nostro." — Freud, *L'interpretazione dei sogni*, 1899

La risoluzione dell'Edipo è la "pietra angolare" della costruzione finale della psiche: struttura l'Io, l'Es, il Super-Io e apre alla vita simbolica (sogni, sublimazioni, identificazioni).

Fissazioni, regressioni e latenza

La **fissazione** è quando l'energia rimane bloccata a un certo stadio. La **regressione** è il ritorno a modalità di funzionamento più antiche in momenti di stress.

La **fase di latenza** (7-12 anni) è un periodo di apparente calma: la rimozione libera molta energia psichica che viene investita nell'apprendimento.

L'eredità di Freud cent'anni dopo

Rimane valida l'idea che **l'essere umano deve fare i conti sia con la realtà esterna che con quella interna delle pulsioni**. La nostra mente è organizzata intorno al funzionamento del corpo — oggi confermato dalla ricerca sull'*embodied cognition* e dagli approcci bottom-up in psicoterapia.

2. Il bebè e la relazione primaria

Il concepimento: biologia e simbolico

Lo sviluppo ha un "**punto zero**" difficile da definire. Il concepimento è allo stesso tempo: - un **atto biologico** (la fecondazione), - un'**operazione immaginativa e mentale**: un uomo e una donna che "concepiscono" — cioè colgono, comprendono — un'idea di famiglia, maternità, paternità.

Missonier parla di **nidazione bio-psichica**: il processo di contenimento somatico e affettivo del bambino che verrà.

Il bebè immaginario, fantasmatico e reale

Durante la gravidanza si costruisce una triade:

Bebè	Descrizione
Immaginario	Rappresentazione consapevole: settimane di gravidanza, ecografie, peso.

Bebè	Descrizione
Fantasmatico	Proiezioni inconsce, personali e transgenerazionali — contorni meno conoscibili ma determinanti.
Reale	Il bambino con il suo temperamento proprio, la sua ritmicità biologica, le sue predisposizioni relazionali.

"La famiglia alleva un bambino venendo allevata da lui." — Ammaniti, 2020

I compiti del neonato: uscire dall'omeostasi intrauterina

1. **Integrare i ritmi** — veglia/sonno, fame/sazietà, azione/riposo.
2. **Sincronizzazione polisensoriale** — riunire i flussi sensoriali dall'esterno.
Perché un oggetto sia sentito come reale, deve essere percepito attraverso almeno **due canali sensoriali sincronizzati**.
3. **Regolazione dello stato di vigilanza (Arousal)** — il livello di disponibilità del bebè agli stimoli.

Golse: *"Questa competenza fondamentale condiziona in qualche modo l'efficacia delle altre competenze di cui dispone."*

Tra corpo e mente: i mediatori adulti

Il neonato deve trovare le prime corrispondenze tra percezioni, sensazioni, emozioni e — più tardi — pensieri. Ci vuole un **interprete adulto** che sostenga questo processo:

- **Rêverie materna** (Bion): il processo attraverso cui nella mente della madre viene dato un significato all'esperienza del bambino.
- **Mirroring** (Fonagy): la capacità della madre di rispecchiare al bambino qualcosa di vivo e coerente riguardo alla sua esperienza.

"Un'anima e un cervello maturi si prendono cura di una mente e un cervello immaturo con amore, regolandone l'attivazione e attribuendo significati all'espressione disordinata di proto-stati emotivi."

Le cure primarie modificano non solo il comportamento ma anche il modo in cui i geni codificano le sinapsi: ormoni del piacere (ossitocina, dopamina) costruiscono sinapsi; ormoni dello stress le distruggono. **La relazione dà forma al cervello.**

La nascita del Sé: tra assenza e presenza

"Il sé trova le sue radici nel punto di convergenza tra assenza e presenza."
— Golse

La ricerca (*Infant research*) mostra che la madre risponde ai segnali del bambino solo il **27% delle volte** — il continuo essere sincroni avrebbe effetti negativi. I **mismatch** (dissincronie) e la loro **riparazione** sono fondamentali per la crescita.

Esperimento della **faccia immobile**: quando la madre assume un'espressione neutra, il bambino tenta di recuperare il contatto, poi si ritira confuso — la riparazione successiva è parte essenziale dello sviluppo.

3. Donald Winnicott: la madre sufficientemente buona

"There is no such thing as a baby"

Winnicott, pediatra e psicoanalista londinese degli anni '40, formula questa frase provocatoria: **non esiste un bebè come entità separata** — esiste sempre una coppia bebè-caregiver. Lo sviluppo si situa al crocevia del registro intrapsichico (dentro di sé) e interpsichico (nella relazione).

La preoccupazione materna primaria

Winnicott chiama **preoccupazione materna primaria** l'identificazione della madre con il bambino — la capacità di empatizzare con i suoi bisogni. È: - un coinvolgimento alterato ma **fisiologico** (non patologico), - basato su identificazione empatica inconscia, - capace di fare "le cose giuste al momento giusto, in modo sufficientemente buono (*good enough*)."

I tre pilastri dell'ambiente facilitante

1. **Holding** (sostenere): tenere fisicamente il bambino. Attraverso il sostegno fisico si costituiscono i **primi confini del Sé** — coesione psicosomatica.
2. **Handling** (manipolazione): le cure corporee attraverso le quali sono veicolati i **primi significati affettivi**. Jeammet: *"La nostra psiche sono le braccia che ci hanno attorniato."*
3. **Object Presenting**: l'ambiente presenta al bambino l'oggetto nel momento in cui il bambino sente di averne bisogno — come se il bambino lo creasse.

Stato simbiotico → De-accomodamento

Inizialmente c'è **dipendenza assoluta**: la madre comprende il bambino per empatia totale. Progressivamente avviene il **de-accomodamento**: aumentano le occasioni in cui la madre è "inadempiente" e attende un segnale. **L'adattamento incompleto ai bisogni rende gli oggetti reali, amati e odiati al contempo.**

Oggetti e fenomeni transizionali

Winnicott introduce i concetti di **oggetto transizionale** e **fenomeni transizionali** per definire l'area intermedia di esperienza tra il pollice e l'orsacchiotto. L'orsacchiotto, il pezzetto di coperta, la filastrocca prima di dormire: sono il **primo possesso "non-me"** del bambino, il ponte tra il mondo soggettivo e quello oggettivamente percepito.

4. La teoria dell'attaccamento: Bowlby e Ainsworth

Il salto paradigmatico

John Bowlby (1907-1990), medico e psicoanalista britannico, fa un'affermazione rivoluzionaria rispetto a Freud:

- **Freud**: il legame madre-bambino si sviluppa attraverso la ricerca di soddisfazione libidica (il bambino si lega a chi lo nutre).

- **Bowlby: l'attaccamento è un fatto primario**, non derivato dall'atto di nutrirsi. Il bisogno di protezione, contatto e conforto è una **motivazione primaria** importante quanto la nutrizione.

Le prove vengono dall'etologia: **Lorenz** → imprinting nelle anatre — seguono il primo oggetto in movimento a prescindere da chi fornisce il cibo. **Harlow** → i macachi preferiscono la "madre di pezza calda" alla "madre di filo metallico che dà latte".

Cos'è l'attaccamento

Attaccamento = sistema innato di comportamenti che spinge il bambino a cercare protezione e vicinanza da una figura di riferimento quando percepisce pericolo o stress. Ha la funzione di garantire sicurezza fisica ed emotiva — base per lo sviluppo socio-emotivo.

Le funzioni dell'attaccamento (Principio D): 1. **Ricerca di prossimità**: promuovere la sicurezza e la sopravvivenza fisica e percepita. 2. **Porto sicuro**: aiutare a regolare le emozioni nei momenti di angoscia. 3. **Base sicura**: consentire l'esplorazione del mondo e lo sviluppo dell'autonomia.

I Modelli Operativi Interni (MOI)

I Modelli Operativi Interni sono pattern cognitivo-affettivi e comportamentali che organizzano l'esperienza relazionale. Contengono le aspettative su come una figura di attaccamento risponderà. Caratteristiche: - **Multipli**: diversi per diversi contesti e relazioni. - Operano **al di fuori della coscienza**. - **Agiscono come filtro percettivo** — colorano come interpretiamo le relazioni.

La Strange Situation (Mary Ainsworth)

Mary Ainsworth (1913-1999) sviluppa la **Strange Situation**: procedura osservativa standardizzata (bambini 12-24 mesi, 8 episodi di 3 minuti ciascuno).

I quattro pattern di attaccamento

Pattern	%	Caregiver	Caratteristiche del bambino
Sicuro	50%	Sintonizzato	Buon arousal; strategie di regolazione autonoma E diadica; attenzione flessibile
Insicuro evitante	25%	Distanziante	Ipoattivazione; regolazione autonoma; attenzione fissata sul gioco
Insicuro ansioso/ambivalente	10%	Preoccupato	Iperattivazione; in allerta; attenzione fissata sul caregiver
Disorganizzato/disorientato	~15%	Spaventante o spaventato	Pattern disorganizzati; sistemi incompatibili attivati; risposte Freeze/Fight/Flight

L'attaccamento disorganizzato: il dramma insolubile

"Quando incontra una figura di attaccamento spaventante o spaventata, il bambino è posto di fronte a un dramma insolubile: la fonte di sicurezza è la fonte di paura." — D. Hill

I pattern insicuri "strutturati" come soluzioni di compromesso

I pattern **evitante** e **ambivalente** sono soluzioni di compromesso per mantenersi regolati malgrado il legame insicuro.

Trasmissione intergenerazionale

La ricerca ha mostrato un significativo rapporto statistico tra: - L'attaccamento della madre (misurato con AAI) e quello del figlio (misurato con SS). - Attaccamento disorganizzato e disturbi psicopatologici.

Ma le relazioni di attaccamento possono essere **diverse e correttive**: insicuro con la madre → sicuro con la maestra/allenatore/nonni. La psicoterapia può svolgere un'azione correttiva.

5. Attaccamento, cultura e prospettiva del ciclo di vita

Il bias culturale

La teoria descrive un sistema biologico umano, ma è inscritta in un momento storico e culturale. Esiste il rischio di un **pregiudizio culturale** nel modo in cui valuta autonomia, esplorazione e indipendenza.

Cultura	Dato
Germania del Nord	Attaccamento evitante più rappresentato
Kibbutz israeliani	Attaccamento ambivalente più presente
Dogon del Mali	81% sicuro, nessuno evitante

Concetti chiave

Termine	Significato
Pulsione	Spinta energetica al confine tra psichico e somatico
Libido	Manifestazione dinamica della pulsione sessuale nella vita psichica
Fissazione	Blocco dell'energia a un determinato stadio psicosessuale
Regressione	Ritorno a modalità di funzionamento più antiche in momenti di stress
Attaccamento	

Termine	Significato
	Sistema innato che spinge alla vicinanza con il caregiver per sicurezza
Monotropismo	Tendenza a formare un legame preferenziale con una sola figura
Modelli Operativi Interni (MOI)	Pattern cognitivo-affettivi che organizzano l'esperienza relazionale
Strange Situation	Metodologia osservativa per valutare i pattern di attaccamento (Ainsworth)
Holding	Sostenere fisicamente il neonato — primo confine del Sé (Winnicott)
Handling	Cure corporee veicolanti i primi significati affettivi (Winnicott)
Rêverie materna	Capacità della madre di dare significato all'esperienza del bambino (Bion)
Mirroring	Rispecchiamento della madre che restituisce un'immagine coerente al bambino (Fonagy)
Oggetto transizionale	Primo possesso "non-me" — area intermedia tra soggettivo e oggettivo (Winnicott)
Mismatch/Riparazione	Dissincronia e successivo recupero nella diade — motori dello sviluppo (Tronick)

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza fondamentale tra la visione di Freud e quella di Bowlby sull'attaccamento? Per Freud il legame madre-bambino è un legame derivato: il bambino si lega a chi lo nutre perché associa la figura alla soddisfazione della pulsione orale. Per Bowlby invece l'attaccamento è un sistema motivazionale primario, biologicamente determinato, del tutto indipendente dalla nutrizione. Le prove vengono dall'etologia: le anatre di Lorenz si imprinting su qualunque oggetto

in movimento, e i macachi di Harlow preferiscono la madre di pezza calda alla madre di metallo che dà latte. Il bisogno di protezione, contatto e conforto è tanto primario quanto la fame.

Cosa sono i Modelli Operativi Interni (MOI) e come influenzano le relazioni? I Modelli Operativi Interni sono pattern cognitivo-affettivi e comportamentali che si formano nelle prime esperienze di attaccamento e organizzano l'esperienza relazionale futura. Contengono aspettative inconsce su come le figure di riferimento risponderanno nei momenti di bisogno. Funzionano come "filtri percettivi" — colorano come interpretiamo le relazioni presenti a partire dalle esperienze passate. Operano al di fuori della coscienza, ma possono essere modificati da esperienze correttive significative.

Cosa si intende per "preoccupazione materna primaria" e per madre "sufficientemente buona" in Winnicott? La preoccupazione materna primaria è uno stato di identificazione empatica intensa della madre con il neonato — quasi fisiologica, non patologica. Permette di fare "le cose giuste al momento giusto." Non richiede perfezione: la ricerca mostra che la madre risponde ai segnali del bambino in modo sintonizzato solo il 27% delle volte. La madre "sufficientemente buona" (good enough) è quella che è abbastanza presente da garantire un ambiente facilitante, ma che gradualmente aumenta le proprie "inadempienze" — permettendo al bambino di imparare che il mondo non corrisponde sempre immediatamente ai suoi bisogni.

Cosa si intende per attaccamento disorganizzato e perché è il pattern più preoccupante? L'attaccamento disorganizzato emerge quando la figura di attaccamento è anche fonte di paura: il bambino si trova in un "dramma insolubile" perché la fonte di sicurezza è la fonte di pericolo. Questo produce l'attivazione simultanea di sistemi contraddittori (fight, flight, freeze) che portano a reazioni disorganizzate. È il pattern statisticamente più correlato a disturbi psicopatologici nell'adulto.

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** le basi biologiche e psicologiche dello sviluppo dell'individuo nei tempi della vita — questa lezione le approfondisce con i modelli teorici principali.
- **Temi aperti da approfondire:**
 - Mentalizzazione (Fonagy, Bateman) — la capacità di leggere gli stati mentali propri e altrui.
 - Approcci bottom-up in psicoterapia: embodied cognition, lavoro corporeo con i traumi.
 - Famiglie contemporanee e genitoriali plurali — come si ridefinisce la "base sicura" in contesti familiari complessi.